医林改错

清 王清任 撰著

53
5

上海科学技术

自　序

余著《医林改錯》一书，非治病全书，乃記脏腑之书也。其中当尙有不实不尽之处，后人倘遇机会，亲见脏腑，精察增补，抑又幸矣！記脏腑后，兼記数症，不过示人以规矩，令人知外感內伤伤人何物，有余不足是何形状。至篇中文义多粗浅者，因业医者学問有浅深也；前后語句多复重者，恐心粗者前后不互証也。如半身不遂內有四十种气亏之症，小儿抽风门有二十种气亏之症，如遇杂症，必于六十种內互考参观，庶免謬誤。望閱是书者，須詳审焉。玉田王清任书

出 版 說 明

《医林改錯》作者王清任(1768～1831),字勛臣,河北省玉田县人,是清代著名的医学家。本书即是他留下来的现在可知的唯一著作。

王清任在医学活动上的特点,是十分重视对于人体內脏的了解,并企图把这种了解和医学理論以及临床实践联系起来。在解剖学上,他通过亲身的观察,对人体內脏的认識,确有新的发现,也改正了前人的一些錯誤。但由于历史条件所限,在观察和分析上,不可避免地有不正确的地方,甚至还有錯誤和粗略之处(如"心无血說"等)。在医学理論方面,他强調和重視气血,根据自己的解剖学观察和临床实践,对气血学說做了新的发揮。现在看来,尽管他的論述的科学依据还嫌不足,但仍可說是补前人之未备。他根据自己对于气血的理解和解剖学的观察,自創方剂三十一个,另修改古人妇产方两个。其立方的主导思想主要是逐瘀活血和补气活血。他所創用的这些方剂,大都出自实践經驗和体会,直至现在还有临床应用参考价值。

《医林改錯》共分两卷:上卷除論述脏腑外,还辨别了五十种血瘀之症,而以三方主治之;下卷主論半身不遂等症,而以一方治之。兹据清道光十年庚寅(1830)刊本重新校勘,并加新式标点符号,除校正文字方面的脫簡、顚倒和謬誤外,又删

节了个别带有封建迷信色彩的提法。由于前面的“张序、刘序、知非子序”与原书关系不大，此次排印亦予删去。本书可供临床医师和研究祖国医学者参考。

科学都是在前人的知識的基础上，經过后人的实践不断发展起来的，医学也是如此。王清任在继承前代医家成就的基础上，根据自己的实践，在医学上許多方面表现了独創的见解，但亦免不了要受个人知識水平和时代条件等方面的限制。对于他在学术上的是非問題一直存在着不同評价。今天我們的任务则在于如何用历史唯物主义观点，根据目前的需要，去批判地吸收他的学說和經驗的合理的有用部分，为现代临床和研究服务。这也就是我們整理重版本书的目的。

上海科学技术出版社

1965年11月

目　录

卷上

医林改錯脏腑記叙 …… 1

古人脏腑图 …… 5

亲见改正脏腑图 …… 6

会厌左气门右气门卫总管荣总管气府血府記 …… 8

津门津管遮食总提瓏管出水道記 ……10

脑髓說 ……12

气血合脉說 ……13

心无血說 ……15

方叙 ……16

通窍活血湯所治症目 ……16

头发脫落 ……16

眼疼白珠紅 ……16

糟鼻子 ……16

耳聋年久 ……17

白癜风 ……17

紫癜风 ……17

紫印脸 ……17

青記脸如墨 ……17

牙疳 ……17

出气臭 ……17

妇人干劳 ……17

男子劳病 ……17

交节病作 ……18

小儿疳証 ……18

通窍活血湯 ……19

加味止痛沒药散 ……19

通气散 ……19

血府逐瘀湯所治症目 ……19

头痛 ……19

胸疼 ……20

胸不任物 ……20

胸任重物 ……20

天亮出汗 ……20

食自胸右下 ……20

心里热名曰灯籠病 ……20

瞀闷 ……20

急躁 ……20

夜睡梦多 ……20

呃逆俗名打咯忒 ……21

飲水即呛 ……21

不眠 ……21

小儿夜啼 ……21

心跳心忙 ……21

夜不安 ……21

俗言肝气病 ……21

干呕 ……21

晚发一陣热 ……21

血府逐瘀湯 ……22

膈下逐瘀湯所治症目 ……22

积块……22
小儿痞块……22
痛不移处……23
臥則腹墜……23
臂泻……23
久泻……23
膈下逐瘀湯……23

卷下

半身不遂論叙……24
半身不遂論……25
半身不遂辨……26
半身不遂本源……27
口眼歪斜辨……28
辨口角流涎非痰飲……28
辨大便干燥非风火……28
辨小便頻数遺尿不禁……29
辨語言蹇澀非痰火……29
辨口噤咬牙……29
記未病以前之形状……30
論小儿半身不遂……31
癱瘓論……31
补阳还五湯……31
瘟毒吐泻轉筋說……32
解毒活血湯……33
急救回阳湯……33
論抽风不是风……34
可保立苏湯……35
論痘非胎毒……36
論痘浆不是血化……38
論出痘飲水即喰……38
論七八天痘疮作痒……39
通經逐瘀湯……39
会厌逐瘀湯……40
止泻調中湯……40
保元化滞湯……40
助阳止痒湯……41
足卫和荣湯……41
少腹逐瘀湯說……42
少腹逐瘀湯……43
怀胎說(兼記难产胎衣不下方)43
古开骨散……44
古沒竭散……44
黄耆桃紅湯……44
古下瘀血湯……44
抽葫芦酒……44
蜜葱猪胆湯……44
蜕蝎皮散……45
小茴香酒……45
痹症有瘀血說……45
身痛逐瘀湯……45
磁砂丸……46
癲狂梦醒湯……46
龙马自来丹……46
黄耆赤风湯……47
黄耆防风湯……47
黄耆甘草湯……47
木耳散……47
玉龙膏(即胜玉膏)……47
辨方效經錯之源 論血化为汗之誤……48

卷　上

医林改錯脏腑記叙

古人曰：既不能为良相，愿为良医。以良医易而良相难。余曰：不然。治国良相，世代皆有；著书良医，无一全人。其所以无全人者，因前人創著医书，脏腑錯誤，后人遵行立論，病本先失，病本既失，总有綉虎雕龙之笔，裁云补月之能，病情与脏腑，絕不相符，此医道无全人之由来也。夫业医診病，当先明脏腑。尝閱古人脏腑論，及所繪之图，立言处处自相矛盾。如古人論脾胃，脾属土，土主静而不宜动，脾动則不安，既云脾动不安，何得下文又言脾聞声則动，动則磨胃化食，脾不动，則食不化，論脾之动静，其錯誤如是；其論肺，虛如蜂窠，下无透窍，吸之則滿，呼之則虛，既云下无透窍，何得又云肺中有二十四孔，行列分布，以行諸脏之气，論肺之孔窍，其錯誤又如是；其論腎，有两枚，即腰子，两腎为腎，中間动气为命门，既云中間动气为命门，何得又云左腎为腎，右腎为命门，两腎一体，如何两立其名，有何凭据，若以中間动气为命门，藏动气者，又何物也，其論腎錯誤又如是；其論肝，左右有两經，即血管，从两胁肋起，上貫头目，下由少腹环繞阴器，至足大指而止，既云肝左右有两經，何得又云肝居于左，左胁属肝，論肝分左右，其錯誤又如是；其論心，为君主之官，神明出焉，意藏于心，意是心之

机，意之所专曰志，志之动变曰思，以思謀远曰虑，用虑处物曰智，五者皆藏于心，既藏于心，何得又云脾藏意智，腎主伎巧，肝主謀虑，胆主决断，据所論，处处皆有灵机，究竟未說明生灵机者何物，藏灵机者何所，若用灵机，外有何神情，其論心如此含混；其論胃，主腐熟水谷，又云脾动磨胃化食，胃之上口名曰賁门，飲食入胃，精气从賁门上輸于脾肺，宣播于諸脉，此段議論，无情无理，胃下口名曰幽门，即小肠上口；其論小肠，为受盛之官，化物出焉，言飲食入小肠，化粪下至闌门，即小肠下口，分别清浊，粪归大肠，自肛门出，水归膀胱为尿，如此論，尿从粪中滲出，其气当臭，尝用童子小便，并問及自飲小便之人，只言味咸，其气不臭，再者食与水合化为粪，粪必涕溏作泻，在鸡鴨无小便則可，在牛马有小便則不可，何况乎人，看小肠化食，水自闌门出一节，眞是千古笑談；其論心包絡，細筋如絲，与心肺相連者，心包絡也，又云心外黄脂是心包絡，又云心下横膜之上，竪膜之下，黄脂是心包絡，又云膻中有名无形者，乃心包絡也，既云有名无形，何得又云手中指之經，乃是手厥阴心包絡之經也，論心包絡竟有如許之多，究竟心包絡是何物，何能有如許之多耶？其論三焦，更为可笑。《灵枢》曰，手少阴三焦主乎上，足太阳三焦主乎下，已是两三焦也。《难經·三十一难》論三焦，上焦在胃之上，主內而不出，中焦在胃中脘，主腐熟水谷，下焦在臍下，主分别清浊，又云三焦者，水谷之道路，此論三焦是有形之物；又云两腎中間动气，是三焦之本，此論三焦是无形之气。在《难經》一有形，一无形，又是两三焦。王叔和所謂有名无状之三焦者，盖由此也。至陈无擇以臍下脂膜为三焦，袁淳甫以人身著內一层，形色最赤者为三焦，虞天民指空控子

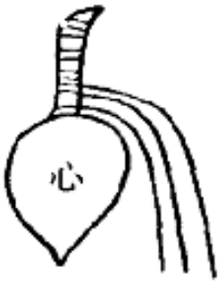
为三焦，金一龙有前三焦、后三焦之論。論三焦者，不可以指屈，有形无形，諸公尙无定准，何得云手无名指之經，是手少阳三焦之經也。其中有自相矛盾者，有后人議駁而未当者。总之，本源一錯，万虑皆失。余尝有更正之心，而无脏腑可见。自恨著书不明脏腑，岂不是痴人說梦；治病不明脏腑，何异于盲子夜行！虽竭思区画，无如之何。十年之久，念不少忘。至嘉庆二年丁巳，余年三十，四月初旬，游于灤州之稻地鎮。其时彼处小儿，正染瘟疹痢症，十死八九，无力之家，多半用代席裹埋。代席者，代棺之席也。彼处乡风，更不深埋，意在犬食，利于下胎不死，故各义冢中，破腹露脏之儿，日有百余。余每日压马过其地，初未尝不掩鼻，后因念及古人所以錯論脏腑，皆由未尝亲见，遂不避污秽，每日清晨，赴其义冢，就群儿之露脏者細視之，犬食之余，大約有肠胃者多，有心肝者少，互相参看，十人之內，看全不过三人，連視十日，大約看全不下三十余人。始知医书中所繪脏腑形图，与人之脏腑，全不相合，即件数多寡，亦不相符；惟胸中膈膜一片，其薄如紙，最关紧要，及余看时，皆以破坏，未能驗明，在心下心上，是斜是正，最为遺憾。至嘉庆四年六月，余在奉天府，有辽阳州一妇，年二十六岁，因疯疾打死其夫与翁，解省拟剮，跟至西关，忽然醒悟，以彼非男子，不忍近前，片刻行刑者提其心与肝肺，从面前过，細看与前次所看相同。后余在京时，嘉庆庚辰年，有打死其母之剮犯，行刑于崇文门外吊桥之南，却得近前，及至其处，虽见脏腑，膈膜已破，仍未得见。道光八年五月十四日，剮逆犯张格尔，及至其处，不能近前。自思一簣未成，不能終止。不意道光九年十二月十三日夜間，有安定门大街板厂胡同恒宅，請余看

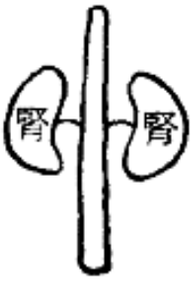
症，因談及膈膜一事，留心四十年，未能审驗明确。內有江宁布政司恒敬公，言伊于膈膜一事，知之最悉。余聞言喜出望外，即拜叩而問之。恒公鉴余苦衷，細細說明形状。余于脏腑一事，訪驗四十二年，方得的确，繪成全图。意欲刊行于世，惟恐后人未见脏腑，議余故叛經文；欲不刊行，复虑后世业医受祸，相沿又不知几千百年。細思黄帝虑生民疾苦，平素以灵枢之言下問岐伯、鬼臾区，故名素問。二公如知之的确，可对君言，知之不确，須待参考，何得不知妄对，遺祸后世？继而秦越人著《难經》，张世賢割裂《河图洛书》为之图注，謂心肝肺以分两計之，每件重几許，大小肠以尺寸計之，每件长若干，胃大几許，容谷几斗几升。其言仿佛似眞，其实脏腑未见，以无凭之談，作欺人之事，利己不过虛名，損人却属实祸。窃財犹謂之盗，偷名岂不为賊！千百年后，岂无知者！今余刻此图，并非独出己见，評論古人之短长；非欲后人知我，亦不避后人罪我，惟愿医林中人，一见此图，胸中雪亮，眼底光明，临症有所遵循，不致南轅北轍，出言含混，病或少失，是吾之厚望。幸仁人君子鉴而諒之！时道光庚寅孟冬直隶玉田县王清任书于京邸知一堂

古人脏腑图

古人所繪脏腑形图如此。

肺六叶、两耳，凡八叶。



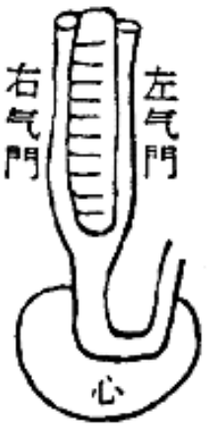


胆附于肝之短叶。

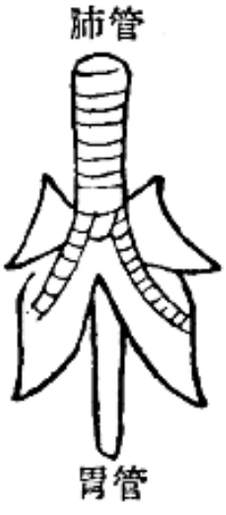
肝左三叶，右四叶，凡七叶。

亲见改正脏腑图

余将亲见諸脏腑显隐之形，繪于其后。



左气门、右气门两管归中一管入心，由心左轉出横行后接卫总管。心长在气管之下，非在肺管之下，心与肺叶上接齐。



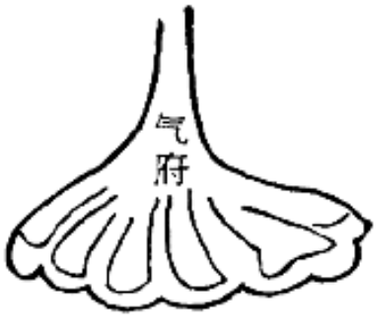
肺管至肺分两杈，入肺两叶，直貫到底皆有节。管内所存皆輕浮白沫，如豆腐沫，有形无体。两大叶大面向背，小面向胸，上有四尖向胸，下一小片亦向胸。肺外皮实无透窍，亦无行气之二十四孔。

膈膜以上仅止肺、心、左右气门，余无他物。其余皆膈膜以下物，人身膈膜是上下界物。

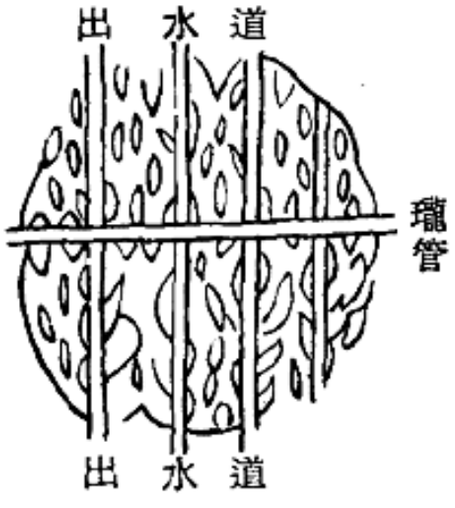
肝四叶，胆附于肝右边第二叶。总提长于胃上，肝又长于总提之上，大面向上，后連于背，肝体坚实，非肠、胃、膀胱可比，絕不能藏血。

胃府之体质，上口賁门在胃上正中，下口幽门亦在胃上偏右，幽门之左寸許名津门，胃内津门之左有疙瘩如枣名遮食，胃外、津门左名总提，肝連于其上。胃在腹是平鋪卧长，上口向背，下口向右，底向腹連出水道。

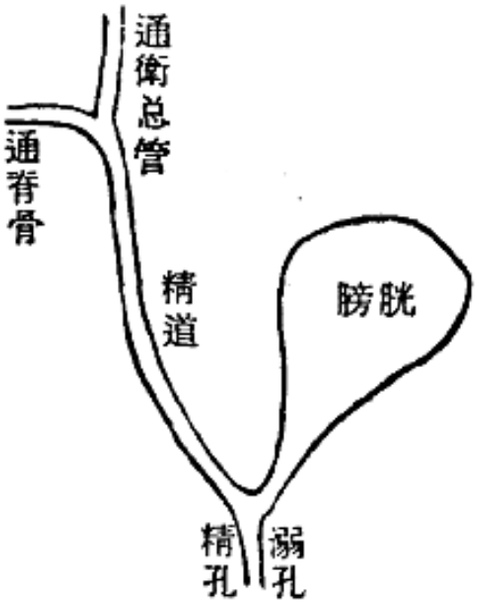
胃中有一管，体象玲瓏，易于出水，故名瓏管。脾之长短与胃相入，于脾中間一管即是瓏管，另画瓏管者，謂有出水道，令人易辨也。



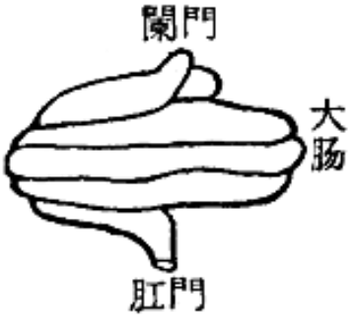
气府俗名鸡冠油，下接抱小肠，气府内、小肠外乃存元气之所，元气化食，人身生命之源全在于此。此系小肠，外有气府包裹之。



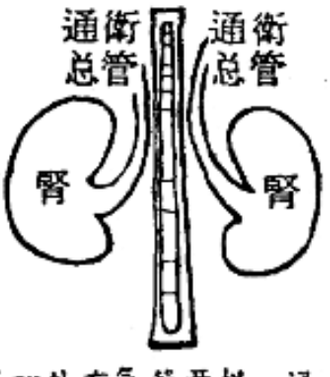
中是瓏管，水由瓏管分流两边出水道，由出水道滲出，沁入膀胱为尿。出水道中有四血管，其余皆系水管。



膀胱有下口，无上口，下口归玉茎。精道下孔亦归玉茎，精道在妇女名子宫。

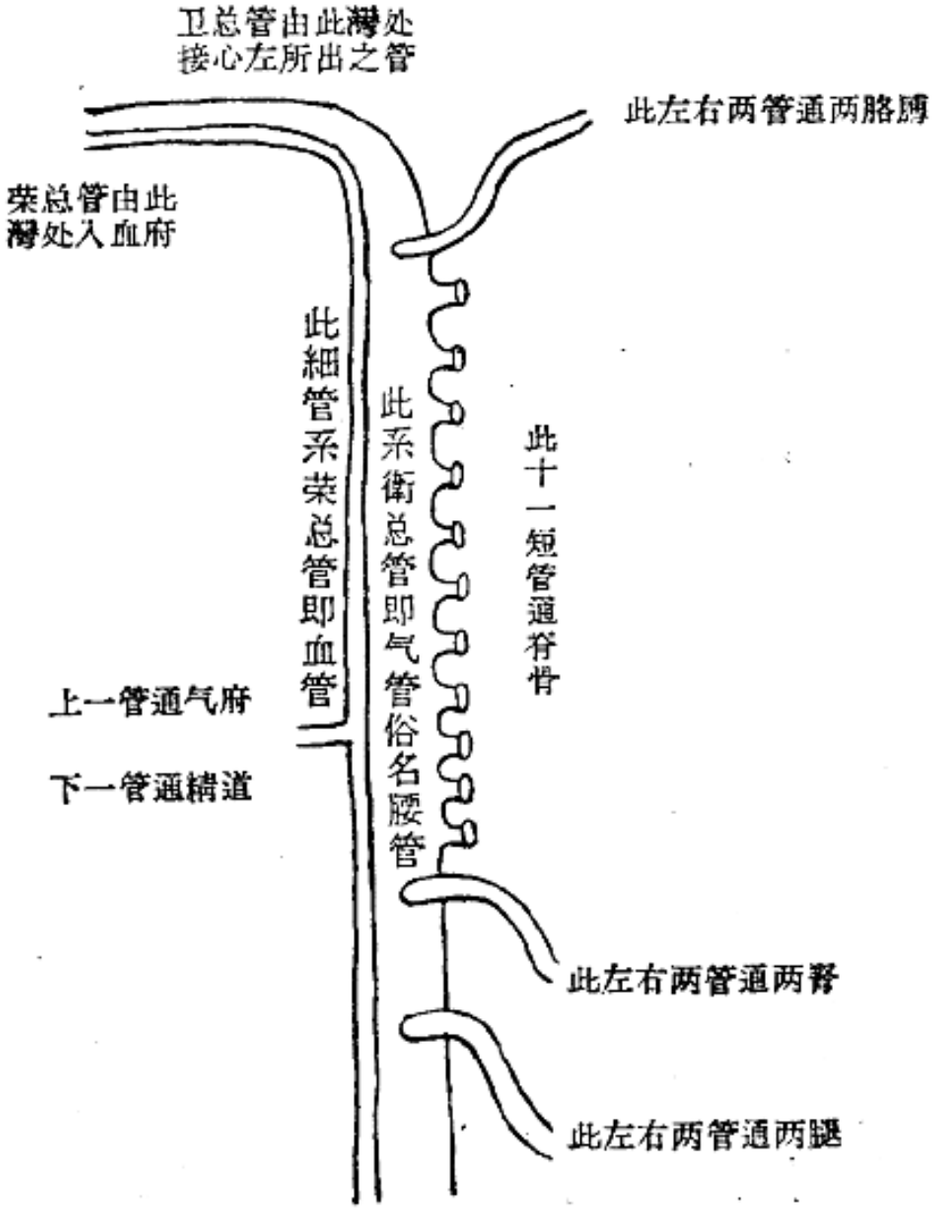


大肠上口即小肠下口，名闌门，大肠下口即肛门。



两腎四处有气管两根，通卫总管，两傍腎体坚实，内无孔窍，绝不能藏精。

舌后白片，名曰会厌，乃遮盖左右气门喉门之物。



古人言經絡是血管，由每脏腑向外长两根，惟膀胱长四根。余亲见百余脏腑，并无向外长血管之形，故书于图后以記之。

会厌左气门右气门卫总管荣总管气府血府記

欲知脏腑体质，先明出气、入气与进飲食之道路。古人謂

舌根后名曰喉，喉者候也，候气之出入，即肺管上口是也。喉之后名曰咽，咽者咽也，咽飲食入胃，即胃管上口是也。謂咽以納食，喉以納气，为千古不易之定論。自灵素至今，四千年来，无人知其錯而改正者。如咽咽飲食入胃，人所共知。惟喉候气之出入一节，殊欠明白。不知肺两叶大面向背，上有四尖向胸，下一小片亦向胸，肺管下分为两杈，入肺两叶，每杈分九中杈，每中杈分九小杈，每小杈长数小枝，枝之尽头处，并无孔窍，其形仿佛麒麟菜，肺外皮亦无孔窍，其内所存，皆輕浮白沫，肺下实无透窍，亦无行气之二十四孔。先賢論吸气則肺滿，呼气則肺虛。此等錯誤，不必細辯。人气向里吸，則肚腹滿大，非肺滿大；气向外呼，則肚腹虛小，非肺虛小。出气、入气、吐痰、吐飲、唾津、流涎，与肺毫无干涉。肺管之后，胃管之前，左右两边凹处，有气管两根，其粗如筋，上口在会厌之下，左曰左气门，右曰右气门，痰飲津涎，由此气管而出。古人誤以咳嗽、喘喘、哮吼等症，为肺病者，因见其症自胸中来。再者，临症查有外感，用发散而愈；有燥痰，用清凉而愈；有积热，用攻下而愈；有气虛，用补中而愈；有阴亏，用滋阴而愈；有瘀血，用逐瘀而愈。扬扬得意，立言著书，以为肺病无疑。不知左气门、右气门两管，由肺管两傍，下行至肺管前面半截处，归并一根，如树两杈归一本，形粗如筋，下行入心，由心左轉出，粗如笔管，从心左后行，由肺管左边，过肺入脊前，下行至尾骨，名曰卫总管，俗名腰管。自腰以下，向腹长两管，粗如筋，上一管通气府，俗名鸡冠油，如倒提鸡冠花之状。气府乃抱小肠之物，小肠在气府是横长，小肠外气府內，乃存元气之所。元气即火，火即元气，此火乃人生命之源。食由胃入小肠，全仗元

气蒸化，元气足則食易化，元气虛則食难化。此記向腹之上一管。下一管，大約是通男子之精道，女子之子宮。独此一管，細心查看，未能查驗的确，所以疑似，以俟后之业医者，倘遇机会，細心查看再补。卫总管，对背心两边，有两管，粗如筋，向两肩长；对腰有两管，通連两腎；腰下有两管，通两胯；腰上对脊正中，有十一短管，連脊此管，皆行气、行津液。气足火旺，将津液煎稠，稠者名曰痰；气虛火衰，不能煎熬津液，津液必稀，稀者名曰飲。痰飲在管，总以管中之气上攻，上行过心，由肺管前气管中，出左右气门。痰飲津涎，本气管中物，古人何以誤为肺中物，因不知肺管前有气管相連而长，止知痰飲津涎自胸中来，便疑为肺中物，总是未亲见脏腑之故。手握足步，头轉身搖，用行舍藏，全凭此气。人气向里吸，則气府滿，气府滿，則肚腹大；气向外呼，則气府虛，气府虛，則肚腹小。卫总管，行气之府，其中无血。若血归气府，血必随气而出，上行則吐血、衄血，下行則溺血、便血。卫总管之前，相連而长，粗如筋，名曰荣总管，即血管，盛血，与卫总管长短相等，其內之血，由血府灌溉。血府即人胸下膈膜一片，其薄如紙，最为坚实，前长与心口凹处齐，从两胁至腰上，順长如坡，前高后低，低处如地池，中存血，即精汁所化，名曰血府。精汁詳胃津门条下。前所言会厌，即舌后之白片，乃遮盖左右气门、喉门之物也。

津门津管遮食总提嚨管出水道記

咽下胃之一物，在禽名曰嗉，在兽名曰肚，在人名曰胃。古人画胃图，上口在胃上，名曰賁门；下口在胃下，名曰幽门。言胃上下两门，不知胃是三门；画胃竪长，不知胃是横长，不但横

长，在腹是平鋪臥长。上口賁门向脊，下底向腹；下口幽门亦在胃上，偏右脇向脊幽门之左寸許；另有一门，名曰津门，津门上有一管，名曰津管，是由胃出精汁水液之道路。津管一物，最难查看，因上有总提遮盖。总提俗名胰子，其体长于賁门之右，幽门之左，正盖津门。总提下前連气府，提小肠，后接提大肠，在胃上后連肝，肝連脊。此是膈膜以下，总提連貫胃肝大小肠之体质。飲食入胃，食留于胃，精汁水液，先由津门流出，入津管。津管寸許外，分三杈。精汁清者，入髓府化髓；精汁浊者，由上杈，臥則入血府，随血化血。其水液，由下杈，从肝之中間，穿过入脾。脾中間有一管，体相玲瓏，名曰瓏管。水液由瓏管分流两边，入出水道。出水道形如鱼网，俗名网油。水液由出水道滲出，沁入膀胱，化而为尿。出水道出水一段，体查最难。自嘉庆二年看脏腑时，出水道有滿水鈴鐺者，有无水鈴鐺者，于理不甚透彻。以后診病，查看久病寿終之人，临时有多飲水者，有少飲水者，有不飲水者，故后其水仍然在腹。以此与前所看者参考，与出水道出水一节，虽然近理，仍不敢为定准。后以畜較之，遂喂遂杀之畜，网油滿水鈴鐺；三四日不喂之畜，杀之无水鈴鐺，則知出水道出水无疑。前言飲食入胃，食留于胃，精汁水液，自津门流出。津门既孔如筋大，能向外流精汁水液，浠粥岂不能流出，津门虽孔如筋大，其处胃体甚厚，四围靠挤縮小，所以水能出而食不能出，况胃之內，津门之左一分远，有一瘩瘩，形如枣大，名曰遮食，乃攙食放水之物，待精汁水液流尽，食方腐熟，漸入小肠，化而为粪。小肠何以化食为粪？小肠外有气府，气府抱小肠，小肠外气府內，乃存元气之所，元气化食。此处与前气府参看。化粪入大肠，自

肛门出。此篇記精汁由胃出津门，生精生血，水液由瓏管出水道，入膀胱为尿，食由胃入小肠，元气蒸化为粪之原委也。

脑髓說

灵机記性，不在心在脑一段，本不当說。纵然能說，必不能行。欲不說，有許多病人不知源始，至此又不得不說。不但医书論病，言灵机发于心，即儒家談道德，言性理，亦未有不言灵机在心者，因始創之人，不知心在胸中，所办何事。不知咽喉两傍，有气管两根，行至肺管前，归并一根，入心，由心左轉出，过肺入脊，名曰卫总管，前通气府、精道，后通脊，上通两肩，中通两臂，下通两腿，此管乃存元气与津液之所。气之出入，由心所过，心乃出入气之道路，何能生灵机，貯記性？灵机記性在脑者，因飲食生气血，长肌肉，精汁之清者，化而为髓，由脊骨上行入脑，名曰脑髓；盛脑髓者，名曰髓海；其上之骨，名曰天灵盖。两耳通脑，所听之声归于脑，脑气虚，脑縮小，脑气与耳窍之气不接，故耳虚聋；耳窍通脑之道路中，若有阻滞，故耳实聋。两目即脑汁所生，两目系如綫，长于脑，所见之物归于脑，瞳人白色，是脑汁下注，名曰脑汁入目。鼻通于脑，所聞香臭归于脑，脑受风热，脑汁从鼻流出，涕浊气臭，名曰脑漏。看小儿初生时，脑未全，顖门軟，目不灵动，耳不知听，鼻不知聞，舌不言。至周岁脑漸生，顖门漸长，耳稍知听，目稍有灵动，鼻微知香臭，舌能言一二字。至三四岁，脑髓漸滿，顖门长全，耳能听，目有灵动，鼻知香臭，言語成句。所以小儿无記性者，脑髓未滿；高年无記性者，脑髓漸空。李时珍曰：脑为元神之府。金正希曰：人之記性皆在脑中。汪訒庵曰：今人每記

忆往事，必閉目上瞪而思索之，脑髓中一时无气，不但无灵机，必死一时，一刻无气，必死一刻。試看癫症，俗名羊羔风，即是元气一时不能上轉入脑髓，抽时正是活人死脑袋；活人者，腹中有气，四肢抽搐，死脑袋者，脑髓无气，耳聋、眼天吊如死。有先喊一声而后抽者，因脑先无气，胸中气不知出入，暴向外出也。正抽时，胸中有漉漉之声者，因津液在气管，脑无灵机之气，使津液吐咽，津液逗留在气管，故有此声。抽后头疼昏睡者，气虽轉入于脑，尙未足也。小儿久病后元气虚抽风，大人暴得气厥，皆是脑中无气，故病人毫无知識。以此参考，岂不是灵机在脑之証据乎？

气血合脉說（脉之形余以实情告后人）

气府存气，血府存血。卫总管，由气府行周身之气，故名卫总管；荣总管，由血府行周身之血，故名荣总管。卫总管，体厚形粗长，在脊骨之前，与脊骨相連，散布头面四肢，近筋骨长，即周身气管；荣总管，体薄形細长，在卫总管之前，与卫总管相連，散布头面四肢，近皮肉长，即周身血管。气在气府，有出有入，出入者，呼吸也，目視耳听，头轉身搖，掌握足步，灵机使气之动轉也。血自血府入荣总管，由荣总管灌入周身血管，滲于管外，长肌肉也。气管近筋骨生，內藏难见；血管近皮肉长，外露易见。气管行气，气行則动；血管盛血，静而不动。头面四肢，按之跳动者，皆是气管，并非血管。如两眉棱骨后凹处，俗名两太阳，是处肉少皮連骨，按之跳动，是通头面之气管。两足大指次指之端，是处肉少皮連骨，按之跳动，是通两足之气管。两手腕横紋高骨之上，是处肉少皮連骨，按之跳

动，是通两手之气管。其管有粗有細，有直有曲，各人体质不同。胳膊肘下，近手腕肉厚，气管外露者短；胳膊肘下，近手腕肉薄，气管外露者长。如外感中人，风入气管，其管必粗，按之出肤。寒入气管，管中津液必凝，凝則阻塞其气，按之跳动必慢；火入气管，火气上炎，按之跳动必急。人壮邪气胜，管中气多，按之必实大有力；人弱正气衰，管中气少，按之必虚小无力。久病无生机之人元气少，仅止上行头面两手，无气下行，故足面按之不动。若两手腕气管上，按之似有似无，或細小如絲，或指下微微乱动，或按之不动，忽然一跳，皆是气将絕之时。此段言人之气管，生平有粗細、曲直之不同。管有短长者，因手腕之肉有薄厚也；按之大小者，虚实也；跳动之急慢者，寒火之分也。前所言，明明是脉，不言脉者，因前人不知人有左气门、右气门，血府、气府，卫总管、荣总管，津门、津管，总提，遮食，瓏管，出水道，在腹是何体质，有何用处。論脏腑、包絡，未定准是何物；論經絡、三焦，未定准是何物，并不能指明經絡是气管、血管；論脉理，首句便言脉为血府，百骸貫通。言脉是血管，气血在內流通，周而复始。若以流通而論，此处血眞能向彼处流，彼处当有空隙之地，有空隙之地，則是血虚，无空隙之地，血流归于何处？古人并不知脉是气管，竟著出許多脉訣，立言虽多，論部位一人一样，并无相同者。古人論脉二十七字，余不肯深說者，非謂古人无容足之地，恐后人对症无論脉之言。診脉断死生易，知病难。治病之要訣，在明白气血。无論外感、內伤，要知初病伤人何物，不能伤脏腑，不能伤筋骨，不能伤皮肉，所伤者无非气血。气有虚实，实者邪气实，虚者正气虚。正气虚，当与半身不遂门四十种气虚之症，小儿

抽风门二十种气虚之症，互相参考。血有亏瘀，血亏，必有亏血之因，或因吐血、衄血，或溺血、便血，或破伤流血过多，或崩漏、产后伤血过多；若血瘀，有血瘀之症可查，后有五十种血瘀症，互相参考。惟血府之血，瘀而不活，最难分别。后半日发烧，前半夜更甚，后半夜輕，前半日不烧，此是血府血瘀。血瘀之輕者，不分四段，惟日落前后烧两时；再輕者，或烧一时。此内烧兼身热而言。若午后身凉，发烧片刻，乃气虚参耆之症；若天明身不热，发烧止一陣，乃参附之症。不可混合从事。

心无血說

余友薛文煌，字朗斋，通州人，素知医，道光十年二月，因赴山东，来舍辞行，閑談言及古人論生血之源，有言心生血，脾統血者，有言脾生血，心統血者，不知宗誰。余曰：皆不可宗，血是精汁入血府所化，心乃是出入气之道路，其中无血。朗斋曰：吾兄所言不实，諸物心皆有血，何独人心无血？余曰：弟指何物心有血？曰：古方有遂心丹治癫狂，用甘遂末，以猪心血和为丸，岂不是猪心有血之凭据？余曰：此古人之錯，非心內之血，因刀刺破其心腔子，內血流入于心，看不刺破之心，內并无血，余见多多，試看杀羊者，割其頸項，不刺心，心內亦无血。又曰：不刺心，何死之速？余曰：滿腔血从刀口流，所以先流者速，继而周身血退还腔子，所以后流者迟，血尽气散，故死之速，如人斗殴破伤，流血过多，气散血亡，漸至抽风，古人立名曰破伤风，用散风药，治死受伤者，凶手拟抵，治一个即是死两个，若明白气散气亡之义，即用黄耆半斤，党参四两，大补其气，救一人岂不是救两人？朗斋点首而别。

方 叙

余不論三焦者，无其事也。在外分头面四肢，周身血管；在內分膈膜上、下两段，膈膜以上，心肺咽喉，左右气门，其余之物，皆在膈膜以下。立通窍活血湯，治头面四肢周身血管血瘀之症；立血府逐瘀湯，治胸中血府血瘀之症；立膈下逐瘀湯，治肚腹血瘀之症。病有千状万态，不可以余为全书。查証有王肯堂《証治准绳》，查方有周定王朱綉《普济方》，查药有李时珍《本草綱目》，三书可謂医学之渊源。可讀可記，有国朝之《医宗金鉴》；理足方效，有吳又可《瘟疫論》。其余名家，虽未见脏腑，而攻发补泻之方，效者不少。余何敢云著书，不过因著医林改錯脏腑图記后，将平素所治气虚、血瘀之症，記数条示人以规矩，并非全书。不善讀者，以余之书为全书，非余誤人，是誤余也。

通窍活血湯所治症目

通窍活血湯所治之病，开列于后。

【头发脫落】 伤寒、瘟病后头发脫落，各医书皆言伤血，不知皮里肉外血瘀，阻塞血路，新血不能养发，故发脫落；无病脫发，亦是血瘀。用药三付，发不脫，十付必长新发。

【眼疼白珠紅】 眼疼白珠紅，俗名暴发火眼。血为火烧，凝于目珠，故白珠紅色。无論有云翳无云翳，先将此药吃一付，后吃加味止痛沒药散，一日二付，三两日必全愈。

【糟鼻子】 色紅是瘀血，无論三二十年，此方服三付，可见效，二三十付可全愈，舍此之外，并无驗方。

【耳聋年久】 耳孔内小管通脑，管外有瘀血，靠挤管闭，故耳聋。晚服此方，早服通气散，一日两付，三二十年耳聋可愈。

【白癜风】 血瘀于皮里，服三五付，可不散漫，再服三十付，可痊。

【紫癜风】 血瘀于肤里，治法照白癜风，无不应手取效。

【紫印脸】 脸如打伤血印，色紫成片，或满脸皆紫，皆血瘀所致，如三五年，十付可愈，若十余年，三二十付必愈。

【青記脸如墨】 血瘀症，长于天庭者多，三十付可愈。白癜、紫癜、紫印、青記，自古无良方者，不知病源也。

【牙疳】 牙者骨之余，养牙者血也。伤寒、瘟疫、痘疹、痞块，皆能烧血，血瘀牙床紫，血死牙床黑，血死牙脱，人岂能活，再用凉药凝血，是促其死也。遇此症，将此药晚服一付，早服血府逐瘀湯一付，白日煎黄耆八錢，徐徐服之，一日服完，一日三付，三日可见效，十日大见效，一月可全愈，纵然牙脱五七个，不穿腮者，皆可活。

【出气臭】 血府血瘀，血管血必瘀，气管与血管相連，出气安得不臭，即风从花里过来香之义。晚服此方，早服血府逐瘀湯，三五日必效。无論何病，聞出臭气，照此法治。

【妇人干劳】 經血三四月不见，或五六月不见，咳嗽喘喘，飲食减少，四肢无力，午后发烧，至晚尤甚，将此方吃三付，或六付，至重者九付，未有不全愈者。

【男子劳病】 初病四肢痿軟无力，漸漸肌肉消瘦，飲食减少，面色黄白，咳嗽吐沫，心煩急躁，午后潮热，天亮汗多。延医調治，始而滋阴，继而补阳，补之不效，則云虚不受补，无可

如何。可笑著书者，不分别因弱致病，因病致弱，果系伤寒、瘟疫大病后，气血虚弱，因虚弱而病，自当补弱而病可痊；本不弱而生病，因病久致身弱，自当去病，病去而元气自复。查外无表症，內无里症，所见之症，皆是血瘀之症。常治此症，輕者九付可愈，重者十八付可愈。吃三付后，如果气弱，每日煎黄耆八錢，徐徐服之，一日服完，此攻补兼施之法；若气不甚弱，黄耆不必用，以待病去，元气自复。

【交节病作】 无論何病，交节病作，乃是瘀血。何以知其是瘀血？每见因血結吐血者，交节亦发，故知之。服三付不发。

【小儿疳証】 疳病初起，尿如米泔，午后潮热，日久青筋暴露，肚大坚硬，面色青黄，肌肉消瘦，皮毛憔悴，眼睛发暗。古人以此症，在大人为劳病，在小儿为疳疾，照前症再添某病，則曰某疳，如脾疳、疳泻、疳肿、疳痢、肝疳、心疳、疳渴、肺疳、腎疳、疳热、脑疳、眼疳、鼻疳、牙疳、脊疳、蛔疳、无辜疳、丁奚疳、哺露疳，分病十九条，立五十方，方內多有梔子、黄連、羚羊、石膏大寒之品。因論病源，系乳食过飽，肥甘无节，停滞中脘，传化迟滞，肠胃漸伤，則生积热，热盛成疳，則消耗气血，煎灼津液，故用大寒以清积热。余初时对症用方，无一效者。后細閱其論，因飲食无节，停滞中脘，此論是停食，不宜大寒之品；以传化迟滞，肠胃漸伤，則生积热之句而論，当是虚热，又不宜用大寒之品。后遇此症，細心审查，午后潮热，至晚尤甚，乃瘀血也，青筋暴露，非筋也，现于皮肤者，血管也，血管青者，內有瘀血，漸至肚大坚硬成块，皆血瘀凝結而成。用通窍活血湯，以通血管；用血府逐瘀湯，去午后潮热；用膈下逐瘀湯，消化积块。三方輪服，未有不愈者。

通窍活血湯

赤　芍一錢　川　芎一錢　桃　仁三錢(研泥)　紅　花三錢

老　葱三根(切碎)　鮮　姜三錢(切碎)　紅　枣七个(去核)　麝　香五厘(絹包)

用黃酒半斤，将前七味煎一钟，去渣，将麝香入酒內，再煎二沸，临臥服。方內黃酒，各处分两不同，宁可多二两，不可少，煎至一钟，酒亦无味，虽不能飲酒之人亦可服。方內麝香，市井易于作假，一錢眞，可合一两假，人又不能辨，此方麝香最要紧，多費数文，必买好的方妥，若买当门子更佳。大人一連三晚吃三付，隔一日再吃三付；若七八岁小儿，两晚吃一付，三两岁小儿，三晚吃一付。麝香可煎三次，再換新的。

〔方歌〕　通窍全凭好麝香，桃紅大枣老葱姜，
　　川芎黃酒赤芍药，表里通經第一方。

加味止痛沒药散　治初起眼疼白珠紅，后起云翳。

沒　药三錢　血　竭三錢　大　黃三錢　朴　硝二錢

石决明三錢(煅)　为末，分四付，早晚清茶調服。眼科外症千古一方。

通气散　治耳聋不聞雷声。余三十岁立此方。

柴　胡一两　香　附一两　川　芎五錢　为末，早晚开水冲服三錢。

血府逐瘀湯所治症目

血府逐瘀湯所治之病，开列于后。

【头痛】　头痛有外感，必有发热、恶寒之表症，发散可愈；有积热，必舌干、口渴，用承气可愈；有气虛，必似痛不痛，用参

者可愈。查患头痛者，无表症，无里症，无气虚、痰飲等症，忽犯忽好，百方不效，用此方一剂而愈。

【胸疼】 胸疼在前面，用木金散可愈；后通背亦疼，用瓜蔞薤白白酒湯可愈。在伤寒，用瓜蔞、陷胸、柴胡等，皆可愈。有忽然胸疼，前方皆不应，用此方一付，疼立止。

【胸不任物】 江西巡撫阿霖公，年七十四，夜臥露胸可睡，盖一层布压則不能睡，已經七年，召余診之，此方五付全愈。

【胸任重物】 一女二十二岁，夜臥令妇人坐于胸方睡，已經二年，余亦用此方，三付而愈。設一齐問病源，何以答之。

【天亮出汗】 醒后出汗，名曰自汗；因出汗醒，名曰盜汗，盜散人之气血。此是千古不易之定論。竟有用补气、固表、滋阴、降火，服之不效，而反加重者，不知血瘀亦令人自汗、盜汗，用血府逐瘀湯，一两付而汗止。

【食自胸右下】 食自胃管而下，宜从正中。食入咽，有从胸右边咽下者。胃管在肺管之后，仍由肺叶之下轉入肺前，由肺下至肝前，出膈膜入腹，肺管正中，血府有瘀血，将胃管挤靠于右。輕則易治，无碍飲食也；重則难治，挤靠胃管，灣而細，有碍飲食也。此方可效，全愈难。

【心里热名曰灯籠病】 身外凉，心里热，故名灯籠病，內有血瘀。认为虚热，愈补愈瘀；认为实火，愈凉愈凝。三两付血活热退。

【昏闷】 即小事不能开展，即是血瘀，三付可好。

【急躁】 平素和平，有病急躁，是血瘀，一二付必好。

【夜睡梦多】 夜睡梦多，是血瘀，此方一两付全愈，外无

良方。

【呃逆俗名打咯忒】 因血府血瘀，将通左气门右气门归并心上一根气管从外挤严，吸气不能下行，随上出，故呃气。若血瘀甚，气管閉塞，出入之气不通，悶絕而死。古人不知病源，以橘皮竹茹湯、承气湯、都气湯、丁香柿蒂湯、附子理中湯、生姜泻心湯、代赭旋覆湯、大小陷胸等湯，治之无一效者。相传咯忒伤寒，咯忒瘟病，必死。医家因古无良法，见此症則弃而不治。无論伤寒、瘟疫、杂症，一见呃逆，速用此方，无論輕重，一付即效。此余之心法也。

【飲水即嗆】 飲水即嗆，乃会厌有血滞，用此方极效。古人評論全錯，余詳于痘症条。

【不眠】 夜不能睡，用安神养血药治之不效者，此方若神。

【小儿夜啼】 何得白日不啼，夜啼者，血瘀也，此方一二付全愈。

【心跳心忙】 心跳心忙，用归脾安神等方不效，用此方百发百中。

【夜不安】 夜不安者，将臥則起，坐未稳又欲睡，一夜无宁刻，重者滿床乱滚，此血府血瘀，此方服十余付，可除根。

【俗言肝气病】 无故爱生气，是血府血瘀，不可以气治，此方应手效。

【干呕】 无他症，惟干呕，血瘀之症，用此方化血，而呕立止。

【晚发一陣热】 每晚內热，兼皮肤热一时，此方一付可愈，重者两付。

血府逐瘀湯

当归三錢 生地三錢 桃仁四錢 紅花三錢
枳壳二錢 赤芍二錢 柴胡一錢 甘草二錢
桔梗一錢半 川芎一錢半 牛膝三錢 水煎服。

〔方歌〕 血府当归生地桃，紅花甘草壳赤芍，
柴胡芎桔牛膝等，血化下行不作劳。

膈下逐瘀湯所治症目

膈下逐瘀湯所治之症，开列于后。

【积块】 积聚一症，不必論古人立五积、六聚、七癥、八瘕之名，亦不議駁其錯，駁之未免过煩。今請問在肚腹能結块者，是何物？若在胃，結者必食也；在肠，結者燥粪也；积块日久，飲食仍然如故，自然不在肠胃之內，必在肠胃之外。肠胃之外，无論何处，皆有气血，气有气管，血有血管，气无形不能結块，結块者，必有形之血也。血受寒，則凝結成块；血受热，則煎熬成块。竪血管凝結，則成竪条，横血管凝結，則成横条，横竪血管皆凝結，必接連成片，片凝日久，厚而成块。旣是血块，当发烧。要知血府血瘀，必发烧，血府血之根本，瘀則殞命；肚腹血瘀，不发烧，肚腹血之梢末，虽瘀不致伤生。无論积聚成块，在左肋、右肋、臍左、臍右、臍上、臍下，或按之跳动，皆以此方治之，无不应手取效。病輕者少服，病重者多服，总是病去药止，不可多服。倘病人气弱，不任克消，原方加党参三五錢皆可，不必拘泥。

【小儿痞块】 小儿痞块，肚大青筋，始終总是血瘀为患，

此方与前通窍活血湯、血府逐瘀湯，三方輪轉服之，月余，未有不成功者。

【痛不移处】 凡肚腹疼痛，总不移动，是血瘀，用此方治之极效。

【臥則腹墜】 病人夜臥，腹中似有物，左臥向左边墜，右臥向右边墜，此是內有血瘀，以此方为主，有杂症，兼以他药。

【腎泻】 五更天泄三两次，古人名曰腎泄，言是腎虚，用二神丸、四神丸等药，治之不效，常有三五年不愈者。病不知源，是难事也，不知总提上有瘀血，臥則将津门攥严，水不能由津门出；由幽门入小肠，与粪合成一处，粪淆溏，故清晨泻三五次。用此方逐总提上之瘀血，血活津门无攥，水出泻止，三五付可全愈。

【久泻】 泻肚日久，百方不效，是总提瘀血过多，亦用此方。

膈下逐瘀湯

灵　脂(炒)二錢	当　归三錢	川　芎二錢	桃　仁(研泥)三錢
丹　皮二錢	赤　芍二錢	乌　药二錢	元　胡一錢
甘　草三錢	香　附錢半	紅　花三錢	枳　壳錢半

水煎服。

〔方歌〕 膈下逐瘀桃牡丹，赤芍乌药元胡甘，
归芎灵脂紅花壳，香附开郁血亦安。

卷　下

半身不遂論叙

医家立言著书，心存济世者，乃良善之心也。必須亲治其症，屡驗方法，万无一失，方可传与后人。若一症不明，留与后人再补。断不可徒取虚名，恃才立論，病未經见，揣度立方。倘病不知源，方不对症，是以活人之心，遺作杀人之事，可不畏歟？如伤寒、瘟疫、杂症、妇科，古人各有所长，对症用方，多半应手取效，其中稍有偏见，不过白玉微瑕。惟半身不遂一症，古之著书者，虽有四百余家，于半身不遂立論者，仅止数人，数人中并无一人說明病之本源，病不知源，立方安得无錯。余少时遇此症，始遵《灵枢》、《素問》、仲景之論，治之无功；继遵河間、东垣、丹溪之論，投药罔效。輾轉躊躇，几至束手。伏思张仲景論伤寒，吳又可著瘟疫，皆独出心裁，并未引古經一語。余空有活人之心，而无济世之手。凡遇是症，必細心研究，审气血之荣枯，辨經絡之通滞，四十年来，頗有所得。欲公之天下，以济后人。奈不敢以管见之学，駁前人之論，另立方法，自取其罪。友人曰：眞胸有确见，屡驗良方，补前人之缺，救后人之难，不但有功于后世，正是前代之勋臣，又何罪之有？余聞斯議，不揣鄙陋，将男妇小儿，半身不遂，瘫腿痿症，抽搐筋攣，得病之源，外现之症，屡驗良法，难治易治之形状，及前人所論脉

理脏腑經絡之錯誤，一一繪图申明其說，詳述前后，以俟高明，再加补助，于医道不无小补云尔。

半身不遂論

半身不遂，病本一体。諸家立論，竟不相同。始而《灵枢經》曰：虛邪偏客于身半，其入深者，內居荣卫，荣卫衰則眞气去，邪气独留，发为偏枯；偏枯者，半身不遂也。《素問》曰：风中五脏六腑之俞所中則为偏风。张仲景曰：夫风之为病，当令人半身不遂。三书立論，本源皆专主于风。至刘河間出世，见古人方論无功，另出手眼，云：中风者，非肝木之风內动，亦非外中于风，良由将息失宜，內火暴甚，水枯莫制，心神昏昧，卒倒无所知。其論专主于火。李东垣见河間方論矛盾，又另立論，曰：中风者，气虛而风邪中之，病在四旬以后，壮盛希有，肥白气虛者間亦有之。論中有中腑、中脏、中血脉、中經絡之分，立法以本气虛外受风邪，是其本也。朱丹溪见东垣方症不符，又分途立論，言西北气寒，有中风，东南气湿，非眞中风，皆因气血先虛，湿生痰，痰生热，热生风也。其論专主于痰，湿痰是其本也。王安道见丹溪論中，有东南气湿非眞中风一句，便云《灵枢》、《素問》、仲景所言，是眞中风，河間、东垣、丹溪所言，是类中风。虞天民言王安道分眞中风、类中风之說，亦未全是，四方病此者，尽因气湿痰火，挾风而作，何尝见有眞中、类中之分？独张景岳有高人之见，論半身不遂，大体属气虛易中风之名，著非风之論，惟引用《內經》厥逆，并辨論寒、热、血、虛，及十二經之见症与症不符，其方不效者，可惜先生于此症，閱历无多。其余名家所論病因，皆是因风、因火、因气、因痰之

論，所立之方，俱系散风、清火、順气、化痰之方。有云气血虛弱而中风邪者，于散风清火方中，加以补气养血之药；有云阴虛亏損而中风邪者，于滋阴补腎药內，佐以順气化痰之品。或补多而攻少，或补少而攻多，自謂攻补兼施，于心有得。今人遵用，仍然无效。又不敢議論古人之非，不曰古方不合今病，便云古今元气不同。既云方不合病，元气不同，何得伤寒病麻黃、承气、陷胸、柴胡，应手取效，何得中风门愈风、导痰、秦艽、三化，屢用无功？总不思古人立方之本，效与不效，原有两途。其方效者，必是亲治其症，屢驗之方；其不效者，多半病由議論，方从揣度。以議論揣度，定論立方，如何能明病之本源。因何半身不遂，口眼歪斜，因何語言蹇澀，口角流涎，因何大便干燥，小便頻数，毫无定见。古人混猜，以一亏損五成元气之病，反用攻发克消之方，安得不錯。溯本穷源，非錯于医，乃錯自著书者之手。嗟呼！此何等事，而竟以意度，想当然乎哉！

半身不遂辨

或曰：半身不遂，古人风火湿痰之論，諸家层次議駁，有証据可凭乎？余曰：即以仲景《伤寒論》中风篇云，中风則令人头疼身痛，发热恶寒，干呕自汗。《金匱要略》論伤风則令人鼻塞噴嚏，咳嗽声重，鼻流清涕；中风本门又云，夫风之为病，当令人半身不遂。今請問何等风，何等中法，令人头疼身痛，发热恶寒，干呕自汗？何等风，何等中法，則令人鼻塞噴嚏，咳嗽声重，鼻流清涕？何等风，何等中法，則令人半身不遂？半身不遂，若果是风，风之中人，必由皮肤入經絡，亦必有由表入里之症可查。尝治此症初得时，并无发热恶寒，头疼身痛，目

痛鼻干，寒热往来之表症。既无表症，则知半身不遂，非风邪所中。再者众人风火湿痰之論，立說更为含混。如果是风火湿痰，无論由外中，由內发，必归經絡。經絡所藏者，无非气血。气血若为风火湿痰阻滞，必有疼痛之症。有疼痛之症，乃是身痛之痹症，非是半身不遂。半身不遂，无疼痛之症。余平生治之最多，从未见因身痛痹症而得半身不遂者。由此思之，又非风火湿痰所中。

半身不遂本源

或曰：君言半身不遂，亏損元气，是其本源，何以亏至五成方病？愿聞其說。余曰：夫元气藏于气管之內，分布周身，左右各得其半。人行坐动轉，全仗元气。若元气足，則有力；元气衰，則无力；元气絕，則死矣。若十分元气，亏二成剩八成，每半身仍有四成，則无病；若亏五成剩五成，每半身只剩二成半，此时虽未病半身不遂，已有气亏之症，因不疼不痒，人自不觉。若元气一亏，經絡自然空虛，有空虛之隙，难免其气向一边归并，如右半身二成半，归并于左，則右半身无气，左半身二成半，归并于右，則左半身无气，无气則不能动，不能动，名曰半身不遂；不遂者，不遂人用也。如睡时气之归并，人不能知觉，不过是醒則不能翻身。惟睡醒时气之归并，自觉受病之半身，向不病之半身流动，比水流波浪之声尤甚。坐时归并，身必歪倒。行走时归并，半身无气，所以跌仆。人便云因跌仆得半身不遂，殊不知非因跌仆得半身不遂，实因气亏得半身不遂，以致跌仆。

口眼歪斜辨

或曰：半身不遂，既然无风，如何口眼歪斜？余曰：古人立歪斜之名，总是临症不細心审查之故。口眼歪斜，并非歪斜。因受病之半脸无气，无气则半脸縮小，一眼无气力，不能圓睜。小眼角下抽，口半边无气力不能开，嘴角上抽，上下相凑，乍看似歪斜，其实并非左右之歪斜。尝治此症，凡病左半身不遂者，歪斜多半在右；病右半身不遂者，歪斜多半在左。此理令人不解，又无书籍可考。何者人左半身經絡，上头面，从右行，右半身經絡，上头面，从左行，有左右交互之义，余亦不敢为定論，以待高明細心审查再补。

又曰：口眼歪斜，尽属半脸无气乎？余曰：前論指兼半身不遂而言。若壮盛人，无半身不遂，忽然口眼歪斜，乃受风邪阻滞經絡之症。經絡为风邪阻滞，气必不上达，气不上达头面，亦能病口眼歪斜，用通經絡散风之剂，一药而愈，又非治半身不遂方之所能为也。

辨口角流涎非痰飲

或曰：口角所流，非痰飲乎？余曰：尝治此症，见所流尽是清水，并非稠痰。明明气虚不固津液，不明此理。試看小儿气不足时，流涎者十有八九，高年人气衰时，流涎者十有二三，再以他症互相参看，流涎者属气虚无疑。

辨大便干燥非风火

或曰：患半身不遂，兼大便干燥，古人名曰风燥，言其病

有风有火，有是理乎？余曰：若是风火，用散风清火潤燥攻下药，大便一行，风散火清，自当不燥。尝见治此症者，誤用下药，下后干燥更甚。总不思平素出大恭时，并非大恭順谷道自流，仍用气力催大恭下行。既得半身不遂之后，无气力使手足动，无气力使舌言，如何有气力到下部催大恭下行。以此推之，非风火也，乃无气力催大恭下行。大恭在大肠，日久不行，自干燥也。

辨小便頻数遺尿不禁

或曰：小便頻数，遺尿，不禁，有火有虛，有分别乎？余曰：有溺尿时玉茎內疼痛，尿一点一滴而出，兼之色紅，乃是火症；若高年人，或虛弱人，尿长而痛，其色清白，乃属气虛。溺孔开张，尿流而不知，名曰遺尿。不禁者，尿欲出而人禁止不溺，尿仍自出。此专指小便自病而言。若半身不遂，兼小便頻数，遺尿，不禁，絕无玉茎疼痛之苦，此是气虛不固提也。

辨語言蹇澀非痰火

或曰：說話不眞，古名語言蹇澀，前人論舌之本有痰有火，此理想来不錯？余曰：非痰火也。舌中原有两管，內通脑气，即气管也，以容气之往来，使舌动轉能言。今半身无气，已不能动，舌亦半边无气，亦不能全动，故說話不眞。試看小儿气不足时，不能行走，高年人气衰时，說話俱不眞，是其証也。

辨口噤咬牙

或曰：既无风火，如何口噤咬牙？余曰：口噤自是口噤，

咬牙自是咬牙，古人以口噤、咬牙混成一症，何临症粗心之甚！口噤是虚，咬牙是实。口噤是牙紧不开，咬牙是叩齿有声。在伤寒、瘟疫、杂症、妇科，有虚症口噤者，有实症咬牙者。独半身不遂，有口噤，絕无咬牙，亦有口噤太甚，下牙里收，其声如鋩，似咬牙，实非咬牙，亦虚症也。如无半身不遂，又无他症相兼，忽然口噤不开，乃风邪阻滞經絡，气不上达之所致，用疏通經絡之剂即愈。

記未病以前之形状

或曰：元气既亏之后，未得半身不遂以前，有虚症可查乎？余生平治之最多，知之最悉。每治此症，愈后問及未病以前之形状，有云偶尔一陣头暈者，有头无故一陣发沉者，有耳内无故一陣风响者，有耳内无故一陣蝉鳴者，有下眼皮长跳动者，有一支眼漸漸小者，有无故一陣眼睛发直者，有眼前长见旋风者，有长向鼻中攢冷气者，有上嘴唇一陣跳动者，有上下嘴唇相凑发紧者，有睡臥口流涎沫者，有平素聪明忽然无記性者，有忽然說話少头无尾語无伦次者，有无故一陣气喘者，有一手长战者，有两手长战者，有手无名指每日有一时屈而不伸者，有手大指无故自动者，有胳膊无故发麻者，有腿无故发麻者，有肌肉无故跳动者，有手指甲縫一陣陣出冷气者，有脚指甲縫一陣陣出冷气者，有两腿膝縫出冷气者，有脚孤拐骨一陣发軟向外棱倒者，有腿无故抽筋者，有脚指无故抽筋者，有行走两腿如拌蒜者，有心口一陣气堵者，有心口一陣发空气不接者，有心口一陣发忙者，有头項无故一陣发直者，有睡臥自觉身子沉者，皆是元气漸亏之症。因不痛不痒，无寒无热，无碍

飲食起居，人最易于疏忽。

論小儿半身不遂

或曰：小儿亦有半身不遂者？余曰：小儿自周岁至童年皆有，突然患此症者少，多半由伤寒、瘟疫、痘疹、吐泄等症，病后元气漸亏，面色青白，漸漸手足不动，甚至手足筋攣，周身如泥塑，皆是气不达于四肢。古人以风治，是于此症閱历无多。

瘫痪論

或曰：元气归并左右，病半身不遂；有归并上下之症乎？余曰：元气亏五成，下剩五成，周流一身，必见气亏諸态。若忽然归并于上半身，不能行于下，則病两腿瘫痪。奈古人論痪症之源，因足阳明胃經湿热，上蒸于肺，肺热叶焦，皮毛憔悴，发为痪症，概用清凉攻下之方。余論以清凉攻下之药，治湿热腿疼痹症則可，治痪症則不相宜。岂知痹症疼痛，日久能令腿瘫，瘫后仍然腿疼；痪症是忽然两腿不动，始終无疼痛之苦。倘标本不清，虚实混淆，岂不遺祸后人。

补阳还五湯 此方治半身不遂，口眼歪斜，語言蹇涩，口角流涎，大便干燥，小便頻数，遺尿不禁。

黄　耆四两(生)　归　尾二錢　赤　芍一錢半　地　龙一錢(去土)

川　芎一錢　桃　仁一錢　紅　花一錢　水煎服。

初得半身不遂，依本方加防风一錢，服四五剂后去之。如患者先有入耳之言，畏惧黄耆，只得迁就人情，用一二两，以后漸加至四两，至微效时，日服两剂，岂不是八两，两剂服五六

日，每日仍服一剂。如已病三两个月，前医遵古方用寒凉药过多，加附子四五錢。如用散风药过多，加党参四五錢，若未服，則不必加。此法虽良善之方，然病久气太亏，肩膀脫落二三指縫，胳膊曲而搬不直，脚孤拐骨向外倒，哑不能言一字，皆不能愈之症，虽不能愈，常服可保病不加重。若服此方愈后，药不可断，或隔三五日吃一付，或七八日吃一付，不吃恐将来得气厥之症。方內黄耆，不論何处所产，药力总是一样，皆可用。

〔方歌〕 补阳还五赤芍芎，归尾通經佐地龙，
四两黄耆为主药，血中瘀滞用桃紅。

瘟毒吐泻轉筋說

上吐下泻轉筋一症，古人立名曰霍乱。宋朝太医院立方，名曰局方，立藿香正气散以治之。以邪气伤正气之病，反用攻伐正气之药，岂不愧太医之名。至我朝道光元年，岁次辛巳，瘟毒流行，病吐泻轉筋者数省，京都尤甚，伤人过多，貧不能葬埋者，国家发帑施棺，月余之間，費数十万金。彼时业医者，有用参朮姜附见效者，便言阴寒；有用芩連梔柏见效者，則云毒火。余曰：非也；不分男妇老少，众人同病，乃瘟毒也。或曰：既是瘟毒，姜附热，芩連凉，皆有见效者，何也？余曰：芩連效在初病人壮毒胜时，姜附效在毒敗人弱气衰时。又曰：有芩連姜附服之不效，而反有害者，何也？余曰：試看針刺而愈者，所流尽是黑紫血，岂不是瘟毒烧炼。瘟毒自口鼻入气管，自气管达于血管，将气血凝結，壅塞津门，水不得出，故上吐下泻，初得用針刺其胳膊肘里灣处血管，流紫黑血，毒随血出而愈。或曰：所刺是何穴？請明白指示。余曰：余虽善針，不必

論，是穴名曰尺泽。人气管周身貫通，血管周身亦貫通。尺泽左右四五根血管，刺之皆出血，皆可愈，尺泽上下，刺之亦可愈。总之，用針所刺而愈，皆风火气有余之症；不足之症，愈針愈坏。此針灸家隐諱而不肯言也。仓卒之时，用針刺，取其捷便也。一面針刺，一面以解毒活血湯治之，活其血，解其毒，未有不一药而愈者。但此症得之最速，伤元气最快，一半日可伤生。若吐泻一两时后，或半日后，一见腿抽，便是腿上气少，一见胳膊抽，便是胳膊上气少。如见眼胞塌陷，汗出如水，肢冷如冰，謾言凉药有害，即余所立解毒活血湯，亦有过无功。此时无論舌干口燥，大渴飲冷，一时飲水数碗，放心用姜附回阳湯，一付可夺命。此法非浅医所能知也。

解毒活血湯

連翹	二錢	葛根	二錢	柴胡	三錢	当归	二錢
生地	五錢	赤芍	三錢	桃仁	八錢(研)	紅花	五錢
枳壳	一錢	甘草	二錢	水煎服。			

〔方歌〕 解毒活血連翹桃，紅花归壳葛赤芍，
柴胡甘草同生地，吐泻良方用水熬。

此方謂初得吐泻而言。若见汗多、肢冷、眼塌，不可用。

急救回阳湯 若吐泻一见轉筋、身凉、汗多，非此方不可。莫畏病人大渴飲冷不敢用。

党参	八錢	附子	八錢(大片)	干姜	四錢	白朮	四錢
甘草	三錢	桃仁	二錢(研)	紅花	二錢		

〔方歌〕 急救回阳参附姜，温中朮草桃紅方，
见眞胆雄能夺命，虽有桃紅气无伤。

解毒活血湯，与急救回阳湯，两方界限分清，未有不应手而愈者。愼之！愼之！

論抽风不是风

夫抽风一症，今人治之不效者，非今人錯治，乃古方誤人。古人不止論病立方誤人，立病名曰抽风，风之一字，尤其誤人。又因此症多半由伤寒、瘟病，或痘疹、吐泄等症，病久而抽，則名曰慢惊风。慢惊风三字，相連立名，更为可笑，不但文义不通，亦未細察病源。若眞是风，风之中人，必由皮肤入經絡，亦必有由表入里之症可查。既查无外感之表症，古人何得著书立方，总言是风。其所以言风者，因见其病发作之时，項背反张，两目天吊，口噤不开，口流涎沫，咽喉痰声，昏沉不省人事，以为中风无疑。殊不知項背反张，四肢抽搐，手足握固，乃气虚不固肢体也；两目天吊，口噤不开，乃气虚不上升也；口流涎沫，乃气虚不固津液也；咽喉往来痰声，非痰也，乃气虚不归原也。如不明此理，試看高年人，久病寿終时，或項强身重，或露睛天吊，或牙紧流涎，或痰声拽鋸，或冷汗淋漓，一派气脫之症，明明显露。以抽风之两目天吊，口噤流涎，痰声拽鋸，互相参看，則抽风之症，气虚无疑。元气既虚，必不能达于血管，血管无气，必停留而瘀，以一气虚血瘀之症，反用散风清火之方，安得不錯。服散风药，无风服之則散气；服清火药，无火服之則血凝；再服攻伐克消之方，气散血亡，岂能望生。溯本穷源，非死于医，乃死于著书者之手。每见业小儿科閱历多者，絕不

誤人，因抽风古方不效，见抽风則弃而不治。亦有高手，看小儿現在之症，知将来必抽风，虽无方調治，亦必告知病家，此病恐将来抽风。何以知其将来必抽风？凡将欲抽风之前，必先见抽风之症，如见頂门下陷，昏睡露睛，口中搖舌，不能啼哭，哭无眼泪，鼻孔煽动，咽喉痰声，头低不抬，口噤无声，四肢冰冷，口吐白沫，胸高如碗，喘噫气促，面色青白，汗出如水，不能裹乳，大便綠色，腹內空鳴，下泄上嗽，肌肉跳动，俱是抽风之兆。前二十症，不必全见，但见一二症，則知将来必抽。其中有可治者，有不可治者，并所用之方，皆开列于后。若露睛天吊，不食不哭，痰鳴气喘，病虽沉重，乃可治之症；若天庭灰色，臀子上縮，或脉微細，或脉全无，外形虽輕，乃不治之症。

可保立苏湯　此方治小儿因伤寒、瘟疫，或痘疹、吐泻等症，病久气虛，四肢抽搐，項背后反，两目天吊，口流涎沫，昏沉不省人事皆效。

黄　耆一两五錢(生)　党　参三錢　白　朮二錢　甘　草二錢
当　归二錢　白　芍二錢　枣　仁三錢(炒)　山　萸一錢
枸杞子二錢　故　紙一錢　核　桃一个(連皮打碎)　水煎服。

此方分两，指四岁小儿而言。若两岁，分两可以减半。若一岁，分两可用三分之一。若两三个月，分两可用四分之一。又不必拘于付数。余治此症，一日之間，常有用两三付者。服至不抽，必告知病家，不可因不抽，遂不服药，必多服数付，气足方妥。

〔方歌〕　可保立苏故紙枣，朮归芍药参耆草，
山萸枸杞水煎服，一个核桃带壳搗。

論痘非胎毒

夫小儿痘疹，自汉至今，著书立方者，不可胜数，大抵不过分順险逆，辨别輕重死生，并无一人說明痘之本源。所以后人有遵保元湯，用黄耆、人参者；有遵归宗湯，用大黄、石膏者；有遵解毒湯，用犀角、黄連者。痘本一体，用药竟不相同。遇順险之痘，查小儿壮弱，分别补泄清凉，用之皆可望生。惟一见逆症，遂无方調治，即云天数当然，此不知痘之本源故也。或曰：古人若不知痘之本源，如何见逆痘便知几天死？余曰：此非古人知痘之本源也。因看痘多，知某日见苗，某日何形，某日何色，某日何症，治之不效，至某日必死。古人知逆痘几天死者，盖由此也。如知痘之本源，岂无方調治？或曰：如君所言，痘之逆症有救乎？余曰：痘之险症，随手而愈，不足論。至于逆症，皆有本源，辨明本源，岂不可救？如余所治，悶症不出，周身攢簇，細密如蚕壳，平板如蛇皮，不热即出，见点紫黑，周身細密无縫，紫白灰色相間，蒙头鎖口，鎖項托腮，皮肉不肿，通身水泡不起胀，行浆不化脓結痂，见点后抽风不止，九窍流血鮮紅，咳嗽声哑，飲水即嗆，六七天作痒抓破无血，七八日泄肚胃口不开，至危之时，头不能抬，足歪不正，两目天吊，項背后反等逆症，初见之时，辨明虛实，皆可望生。明此理者，知余补前人之未及，救今人之疑难；不明此理者，妄加評論，以余言为狂妄，而不知非狂也，知痘之本源也。不似諸家議論，出痘总是胎毒。諸书又曰，自汉以前无出痘者。既云胎毒，汉以前人独非父母所生。此論最为可笑。若依古人之論，有謂胎毒藏于脏腑，而何以未出痘以前，脏腑安然无病？有謂胎毒藏于肌肉，

而何以未出痘以前，皮肤更不生疮？又有謂胎毒藏于骨髓，或因惊恐跌仆，或因伤食感冒，触动其毒，发为天花。信如斯言，因惊恐跌仆，伤食感冒，触动而发，則是自不小心；伏思出花正盛时，非止一人出花，少則一方，多則数省，莫非数省之人，同时皆不小心？此論更为无理。再见世上种痘之医，所种之痘，无論多少，无一不順。若是胎毒，毒必有輕重，毒重者痘必险，何以能无一不順？由此思之，如何胎毒二字，牢不可破，殊不知痘非胎毒，乃胞胎內血中之浊气也。儿在母腹，始因一点眞精，凝結成胎以后，生长脏腑肢体，全賴母血而成，胞胎內血中浊气，降生后仍藏荣血之中，遇天行触浊气之瘟疫，由口鼻而入气管，由气管而达血管，将血中浊气逐之自皮肤而出，色紅似花，故名天花；形圓如豆，故名曰痘。总之，受瘟疫輕，瘟毒随花而出，出花必順；受瘟疫重，瘟毒在內逗遛，不能随花而出，出花必险；受瘟疫至重，瘟疫在內烧炼其血，血受烧炼，其血必凝，血凝色必紫，血死色必黑，痘之紫黑，是其証也，死血阻塞道路，瘟疫之毒，外不得由皮肤而出，必內攻脏腑，脏腑受毒火煎熬，随变生各脏逆症。正对痘科书中所言某經逆痘，不知非某經逆痘也，乃某經所受之瘟毒也。痘之順逆，在受瘟疫之輕重。治痘之紧要，全在除瘟毒之方法。瘟毒不除，花虽少而必死；瘟毒若除，花虽多不致伤生。痘科书中但論治胎毒，而不知治瘟毒，纵知治瘟毒，而不知痘毒巢穴在血。若辨明瘟毒輕重，血之通滞，气之虛实，立救逆痘于反掌之間，此所謂知其要者，一言而終耳。

論痘浆不是血化

痘出时是紅色，五六天后忽变清浆，次变白浆，次变混浆，次变黄脓，終而結痂。古人謂痘浆总是血化，若是血化，紅血必能变白色，今請以血一盞試之，或以矾清，或以火熬，能使之变清水、白浆、混浆、黄脓乎？痘本血管內血中浊气，遇天行逐浊气之瘟疫，自口鼻而入于气管，达于血管，将血管中浊气与血，并气管中津液，逐之自毛孔而出，所以形圓色紅。五六天后痘中之血，仍退还血管，痘內止存浊气津液，津液清，名曰清浆。清浆为瘟毒烧炼，稠而色白，故名白浆。白浆再炼，更稠而混，故名混浆。混浆再炼，稠如疮脓，故名黄脓。将黄脓炼乾而結痂。痘不行浆，皆因血不退还血管，血不退还血管，皆因血管內有瘟毒烧炼，血凝阻塞血之道路，若通血管之瘀滞，何患浆之不行？

論出痘飲水即嗆

出痘有四五天、七八天飲水即嗆者，古人論毒火壅于咽喉，列于不治之症。总是不明咽喉左右气门之体质。舌后为喉，即肺管。喉后为咽、即胃管。咽前喉后，两边凹处有气管两根，名左气门、右气门。舌根有一白片，其厚如錢，名曰会厌，正盖肺管左右气门上口。人咽飲食，必以舌尖抵上腭，使会厌将肺管与左右气门盖严，飲食方可过肺管左右气门，入后之胃管。試看人吃飯，飲食将入嗓至喉。未入咽时，或忽然冷笑，气暴上冲，会厌一开，或一粒米，一滴水，入左右气门，立刻由鼻嗆出，是其証也。今瘟毒烧炼会厌，血凝不能盖严气门，

故飲水滲入即嗆。食不嗆者，因微微小縫能滲水而食不能入，故不嗆。化开会厌中瘀血，其嗆立止。

論七八天痘疮作痒

痘疮作痒者，当先分明皮肤。皮是皮，肤是肤，皮肤不分，如何能明痘疮作痒之本源？如人湯燙火烧，随起一泡，其薄如紙，即是肤；肤里肉外厚者是皮。痘至六七天，瘟毒浊气津液尽归于皮之外，肤之內。痘窠之中，正气虚，不能达痘中行浆、化脓、結痂，以致瘟毒外不得出肤，內不得入皮，毒在皮外肤里，故作痒。医家遵《素問》諸疮痛痒皆属于火之句，随用清凉之品，克伐生气，不但作痒不止，胃气轉伤。有专用补气者，气愈补而血愈瘀，血瘀气更不能外达于皮肤，此时用补气破血之剂，通开血道，气直达于皮肤，未有不一药而痒即止者。

通經逐瘀湯　此方无論痘形攢簇，蒙头覆釜，周身細碎成片，或夹疹夹斑，浮衣水泡，其色或紫、或暗、或黑，其症或乾呕、煩躁、昼夜不眠，逆形逆症，皆是瘀血凝滞于血管，并宜用此方治之。其方中药性，不大寒大热，不大攻大下，眞是良方也。

桃仁八錢(研)　紅花四錢　赤芍三錢　山甲四錢(炒)
皂刺六錢　連翹三錢(去心)　地龙三錢(去心)　柴胡一錢
麝香三厘(絹包)　水煎服。

大便乾燥，加大黃二錢，便利去之。五六日后，见清浆、白浆，将麝香去之，加黃耆五錢，将山甲、皂刺减半。至七八日后，桃仁、紅花亦减半，黃耆可用八錢。

此方指四五岁而言。若一二岁，分两可减半。若八九岁，

分两可加一半。

〔方歌〕 通經甲皂麝香龙，逐瘀赤芍桃与紅，
連翘柴胡毒可解，便乾微用大黄攻。

会厌逐瘀湯 此方治痘五六天后，飲水即嗆。

桃仁(炒)五錢 紅花五錢 甘草三錢 桔梗三錢
生地四錢 当归二錢 元参一錢 柴胡二錢
枳壳二錢 赤芍二錢 水煎服。

此方指五六天后嗆水而言。若痘后抽风兼飲水即嗆者，乃气虚，不能使会厌盖严气管，照抽风方治之。

〔方歌〕 会厌逐瘀是病源，桃紅甘桔地归元，
柴胡枳壳赤芍药，水嗆血凝立可痊。

止泻調中湯 治痘六七日后泄泻不止，或十余日后泄泻，皆治之。

黄耆八錢 党参三錢 甘草二錢 白朮二錢
当归二錢 白芍二錢 川芎一錢 紅花三錢
附子(制)一錢 良姜五分 官桂五分(去粗皮) 水煎服。

此方指痘六七天后泄泻而言。痘后抽风兼泄泻者，亦效。不是初出痘泄泻之方。

〔方歌〕 止泻調中参草耆，朮归芍药芎紅随，
附子良姜桂少用，气虚泄泻总相宜。

保元化滞湯 治痘五六日后痢疾，或白，或紅，或紅白相杂，皆治之。

黄　耆一两(煎湯冲)　滑　石一两(末)　晚服加白沙糖五錢更妙。

此方乃余之心法，不独治小儿痘症痢疾，大人初痢、久痢，皆有奇效。然大人初痢，滑石用一两五錢，白糖一两，不必用黄耆；久痢加黄耆，滑石仍用一两五錢。

〔方歌〕　保元化滯补攻方，一两黄耆煎作湯，
　　为末滑石須一两，冲服痢止气无伤。

助阳止痒湯　治痘六七日后，作痒不止，抓破无血，兼治失音声哑。

黄　耆一两　桃　仁二錢(研)　紅　花二錢　皂　刺一錢
赤　芍一錢　山　甲一錢(炒)

此方治痘后六七日，作痒甚者，抓破无血。不是治初出痘一二日作痒之方。

〔方歌〕　助阳止痒耆桃仁，皂刺赤芍山甲同，
　　声哑失音同一治，表虚因里气不行。

足卫和荣湯　治痘后抽风，两眼天吊，項背反张，口噤不开，口流涎沫，昏沉不醒人事，周身潰烂，脓水直流，皆治之。

黄　耆一两　甘　草二錢　白　朮二錢　党　参三錢
白　芍二錢　当　归一錢　枣　仁二錢　桃　仁一錢五分(研)
紅　花一錢五分　水煎服。

此方专治痘后抽风，及周身潰烂。若因伤寒、瘟疫、杂症，疾久气虚抽风，抽风门另有专方。

〔方歌〕　足卫和荣耆草朮，参芍归枣桃紅扶，
　　抽风风字前人誤，服此还阳命可苏。

少腹逐瘀湯說

此方治小腹积块疼痛，或有积块不疼痛，或疼痛而无积块，或少腹胀滿，或經血见时，先腰痠少腹胀，或經血一月见三五次，接連不断，断而又来，其色或紫、或黑，或块，或崩漏，兼少腹疼痛，或粉紅兼白带，皆能治之，效不可尽述。

更出奇者，此方种子如神，每經初见之日吃起，一連吃五付，不过四月必成胎。必須男女年岁，与月合成阳数方生子，如男女两人，一单岁，一双岁，必擇双月方生子；如两单岁，或两双岁，必擇单月方生子。擇月不可以初一为定准，以交节为定准。要知偶有經过二十日結胎者，切記准日期。倘月分不对生女，莫謂余方不驗。余用此方，效不可以指屈。

道光癸未年，直隶布政司素納公，年六十，因无子甚忧，商之于余。余曰：此易事耳。至六月，令其如君服此方，每月五付，至九月怀孕，至次年甲申六月二十二日生少君，今七岁矣。此方更有险而不险之妙。孕妇体壮气足，飲食不减，并无伤損，三个月前后，无故小产，常有連伤数胎者，医书頗多，仍然議論滋阴养血，健脾养胃，安胎保胎，效方甚少。不知子宫內先有瘀血占其地，胎至三月再长，其內无容身之地，胎病靠挤，血不能入胎胞，从傍流而下，故先见血。血既不入胎胞，胎无血养，故小产。如曾經三月前后小产，或連伤三五胎，今又怀胎至两个月前后，将此方服三五付，或七八付，将子宫內瘀血化淨，小儿身长有容身之地，断不致再小产。若已經小产，将此方服三五付，以后成胎，可保无事。此方去疾、种子、安胎，尽善尽美，眞良善方也。

少腹逐瘀湯

小茴香七粒(炒)　乾姜二分(炒)　元胡一錢　沒药二錢(研)

当归三錢　川芎二錢　官桂一錢　赤芍二錢

蒲黃三錢(生)　灵脂二錢(炒)　水煎服。

〔方歌〕少腹茴香与炒姜，元胡灵脂沒芎当，

蒲黃官桂赤芍药，种子安胎第一方。

怀胎說(兼記难产胎衣不下方)

古人論胎在子宫，分經輪养：一月肝經养，二月胆經养，三月心經养，四月三焦养，五月脾經养，六月胃經养，七月肺經养，八月大肠养，九月腎經养。若依其論，胎至两月，自当肝經交代，胆經接班。此論实在无情无理。儿在母腹，全賴母血而成，一言可了，何必图取虛名，故作欺人之論。又如子啼门云：儿在母腹，口含臍带落落，吮血养生。請問初結胎无口时，又以何物吮血养生？既不明白，何不归而謀諸妇，訪問收生婆。訪問的确再下笔，断不致遺笑后人。岂知結胎一月之內，并无胎衣。一月后两月內，始生胎衣。胎衣既成，儿体已定。胎衣分两段，一段厚，是双层，其內盛血；一段薄，是单层，其內存胎。厚薄之間，夹縫中长一管，名曰臍带，下連儿臍。母血入胎衣內盛血处，轉入臍带，长脏腑肢体，周身齐长，并非先长某脏，后长某腑。一月小产者，并无胎衣。两月小产者，有胎衣，形如秤錘，上小下大，不过三指长短。三月小产者，耳目口鼻俱备，惟手足有拳不分指。至月足临生时，儿蹬破胎衣，头轉向下而生，胎衣随胎而下，胎衣上之血，随胎衣而下，此其长

也。最关紧要是难产，古人原有开骨散，服之有效者，有不效者，其方总論活血开骨，不重用力劳乏。余每用开骨散，重加黄耆，不过一时胎即下。至胎衣不下，古人原有沒竭散，始而用之，有效，有不效，继而加倍用之，胎衣立下。药味要紧，分两更要紧。

古开骨散 治难产。

当归一两 川芎五錢 龟板八錢 血余一团(烧灰)

加生黄耆四两。水煎服。

古沒竭散 治胎衣不下。

沒药三錢 血竭三錢 为末，滚水調服。

黄耆桃紅湯 治产后抽风，两目天吊，口角流涎，項背反张，昏沉不省人事。

黄耆八两(生) 桃仁三錢(研) 紅花二錢 水煎服。

妇科以《济阴綱目》为最，《医宗金鉴》擇其方論，纂为歌訣，令人易讀易記，惟抽风一症，方不效，余已补之。

古下瘀血湯 治血鼓。何以知是血鼓？腹皮上有青筋，是血鼓腹大。

桃仁八錢 大黄五分 蠐虫三个 甘遂五分(为末冲服，或八分)

水煎服。与前膈下逐瘀湯，輪流服之安。

抽葫芦酒 治腹大周身肿。

自抽乾葫芦，焙为末，黄酒調服三錢。若葫芦大，以黄酒入內煮一时，服酒頗效，取其自抽之义。

蜜葱猪胆湯 治通身肿，肚腹不大。

猪　胆一个(取汁)　白　蜜四两(两味調和一处)　葱　头四个(带白一寸)　黄　酒半斤

用酒煎葱两三沸，将酒冲入蜜胆內，服之立效。

蜊蝟皮散　治遺精，梦而后遺，不梦而遺，虛实皆效。

蜊蝟皮一个，瓦上焙为末，黄酒調，蚤服。实在效，眞难吃。

小茴香酒　治白浊，俗名騙白，又名下淋，精道受风寒，药全不效。

小茴香一两炒黄，为粗末，黄酒半斤烧滚冲，停一刻，去渣服酒。

痹症有瘀血說

凡肩痛、臂痛、腰疼、腿疼，或周身疼痛，总名曰痹症。明知受风寒，用温热发散药不愈；明知有湿热，用利湿降火药无功。久而肌肉消瘦，議論阴亏，随用滋阴药，又不效。至此便云病在皮脉，易于为功；病在筋骨，实难见效。因不思风寒湿热，入皮肤何处作痛。入于气管，痛必流走；入于血管，痛不移处。如論虛弱，是因病而致虛，非因虛而致病。总滋阴，外受之邪，归于何处？总逐风寒、去湿热，已凝之血，更不能活。如水遇风寒，凝結成冰，冰成风寒已散。明此义，治痹症何难。古方頗多，如古方治之不效，用身痛逐瘀湯。

身痛逐瘀湯

秦　艽一錢　川　芎二錢　桃　仁三錢　紅　花三錢

甘　草二錢　羌　活一錢　沒　药二錢　当　归三錢

灵　脂二錢(炒)　香　附一錢　牛　膝三錢　地　龙二錢(去土)

若微热，加蒼朮、黄柏。若虛弱，量加黄耆一二两。

〔方歌〕 身痛逐瘀膝地龙，羌秦香附草归芎，
黄耆蒼柏量加减，要紧五灵桃没紅。

硇砂丸 治瘰癧鼠疮，满項满胸，破烂流脓，无不应手取效。

硇砂二錢(研細) 皂角子一百个 乾醋一斤(前二味入醋內浸三日)

入砂鍋內熬之，将乾，将鍋子硇砂，拌于皂子上，候乾，以微火焙乾，或以炉台上炕之。每晚嚼五粒，或八粒，一日蛋晚或吃二次，以滚白水送。然乾則皂子过硬，为末服亦可。方內硇砂，有紅、白二种。余所用，是紅色者。未知白色硇砂，功效若何。硇砂紅色者，出庫车北山洞中，夏令从洞中出火，人不能近前，冬令回民赤身近洞取之。本草言西域盐卤熬成者，誤也。

癫狂梦醒湯 癫狂一症，哭笑不休，詈駡歌唱，不避亲疏，許多恶态，乃气血凝滞脑气，与脏腑气不接，如同作梦一样。

桃仁八錢 柴胡三錢 香附二錢 木通三錢
赤芍三錢 半夏二錢 腹皮三錢 青皮二錢
陈皮三錢 桑皮三錢 苏子四錢(研) 甘草五錢

水煎服。

〔方歌〕 癫狂梦醒桃仁功，香附青柴半木通，
陈腹赤桑苏子炒，倍加甘草緩其中。

龙马自来丹

马前子八两 地龙八条(去土，焙乾为末) 香油一斤

将香油入鍋內熬滚，入马前子煠之，得马前子微有响爆之声，拿一个用刀切两半，看其內以紫紅色为度，研为細末，再入前地龙末，和均，面糊为丸，綠豆大。每付吃三四分，临床服，盐水送。若五

六岁小儿，服二分，紅糖水送。如不为丸，面子亦可服。如吃斋人，去地龙亦可。

治癇症，俗名羊羔风，每晚先服黄耆赤风湯一付，临臥服丸药一付，吃一月后，不必服湯药，淨吃丸药，久而自愈，愈后将丸药再吃一二年，可保除根。病源記前"脑髓說"中。

黄耆赤风湯

黄　耆二两(生)　赤　芍一錢　防　风一錢　水煎服。小儿減半。

治瘫腿，多用一分，服后以腿自动为准，不可再多。如治諸疮諸病，或因病虚弱，服之皆效。无病服之，不生疾病。总书数篇，不能言尽其妙。

此方治諸病皆效者，能使周身之气通而不滞，血活而不瘀，气通血活，何患疾病不除。

黄耆防风湯　治脫肛，不論十年八年，皆有奇效。

黄　耆四两(生)　防　风一錢　水煎服。小儿減半。

黄耆甘草湯　治老年人溺尿玉茎痛如刀割，不論年月深久，立效。

黄　耆四两(生)　甘　草八錢　水煎服。病重一日两付。

木耳散　治溃烂諸疮，效不可言。不可輕視此方。

木　耳一两(焙乾，研末)　白沙糖一两(和匀)　以温水浸如糊，敷之縛之。

此方与蜊蝟皮治遺精，抽葫芦治鼓症，义同。明此义，方可以学医。

玉龙膏(即胜玉膏)　治跌打損伤，貼之頗效。

香	油一斤	白	蔹	升	麻	当	归
川	芎	連	翹	銀	花	甲	片
川	乌	象	皮各四錢	乳	香一錢半(末)	沒	药一錢半(末)
輕	粉三錢(末)	冰	片三分(末)	麝	香三分(末)	白	占二两

将前九味药，入油內煉枯色，去渣，入宫粉三盒，离火，再入乳、沒、冰片、麝，搅均，再将白占投入于內摊貼之。此膏去宫粉，即糕子药，貼破烂諸疮，其效如神。

木耳散、玉龙膏，溃烂諸疮，可靠之良方也，不可輕視。

辨方效經錯之源　論血化为汗之誤

胞侄作礪来京，见脏腑图記問曰：伯父所繪之图，經絡是气管，皆本于卫总管，由卫总管散布周身，是周身經絡通連，并非各脏腑长两經。侄思古人若不明經絡，何以张仲景著伤寒，按足六經之现症，立一百一十三方，分三百九十七法，其方效著頗多，侄不解其理。余曰：尔看其首篇，細心研究，便知其方效論錯之理。如首篇論足太阳膀胱經，为寒邪所伤，則令人头疼、身痛、項强、发热、恶寒、乾呕、无汗，用麻黃湯治之；若諸症如前而有汗，是伤风，用桂枝湯治之。所論是足太阳經，足太阳专通两足，而不通两手。其論传邪，传足六經，不传手六經。尔看初得伤寒，头疼、身痛、項强、发热、恶寒，未有两胳膊、两手不疼痛发热恶寒者，用麻黃湯，亦未有周身皆愈，而独不愈两胳膊、两手者。岂不是方虽效而論經絡实錯之明証？若仲景以前，有人亲见脏腑，著明經絡貫通，仲景著伤寒，必言外感寒邪，入周身之經絡，用麻黃湯发散周身之寒邪，一言可了。論

有汗是伤风，以桂枝湯治之，以桂枝、白芍、甘草三味，然从未见治愈一人。桂枝湯所以不见效者，因头疼身痛，发热有汗，非伤风症也，乃吳又可所論之瘟疫也。又問：寒邪在表，自当见头疼身痛，发热恶寒，无汗之表症。初得伤寒，尙未传里，如何即有作呕之里症？仲景著論，王叔和等数十人注释，并未說明表症作呕之所以然。侄实不能明白，求伯父明白指示。余始看尔不过有讀书之志，而无业医之才，今据尔此問，尙有思路，将来不致粗心，輕忽人命。尔問寒邪在表，如何有作呕之里症，余詳細告汝：寒邪始入毛孔，由毛孔入皮肤，由皮肤入孙絡，由孙絡入阳絡，由阳絡入經，由經入卫总管，由卫总管横行入心，由心上行入左右气管，由左右气管上攻左右气门，故作呕。此表症所以作呕之本源也。用麻黃湯服之入胃，其药汁由津门流出，入津管，过肝，入脾中之瓏管，从出水道滲出，沁入膀胱为尿；其药之气，即药之性，由津管达卫总管，由卫总管达經，由經达絡，由絡达孙絡，由孙絡达皮肤，由皮肤达毛孔，将寒邪逐之自毛孔而出，故发汗，邪随汗出，汗出邪散，故呕即止。此周身經絡，內外貫通，用麻黃湯发散表邪，随汗而出之次第也。又問：仲景論目痛、鼻乾、不得眠，是足阳明胃經之表症，以葛根湯治之，其方內有葛根，仍有麻黃，此理不甚明白。余曰：寒邪由表入經絡，正气将寒邪化而为热，故名曰邪热，邪热上攻头頂，脑为邪热所扰，故不得眠；目系通于脑，邪热由脑入目，故目痛；鼻通于脑，邪热由脑入鼻，故鼻乾。明是邪热上攻之火症，并非足阳明胃經之表寒，用葛根而愈者，莫謂葛根是温散之品，葛根乃清散之药也；其方內用麻黃者，发散在表未化之寒邪也。此又是方效經絡錯之明証。又問：仲

景論胸胁痛、耳聋、口苦、寒热往来而呕，其症在半表半里，是足少阳胆經之症，用小柴胡湯治之，其方神效。侄思此症，若不在胆經，其方又神效，若在胆經，胆又居膈膜之下，其痛又在胸胁，此一段侄又不明白。余曰：尔看脏腑图，膈膜以上之血府便明白。邪热入于血府，攻击其血，故胸胁作痛；邪向血內攻，血向外抗拒，一攻一拒，故寒热往来；热灼左右气门，气上下不通，故呕而口苦；邪热上攻，故耳聋目眩；柴胡能解血府之热，热解汗自出，邪随汗解，故效甚速。此亦是方效論經錯之明証。至传变多端，总不外表里虚实。尔若明伤寒，須看吳又可之瘟疫。若见书少，必有偏寒偏热之弊。昨晚尔当客問：古人言汗在皮肤是血，发于皮肤外是汗，言汗即血化，此理尔不解。彼时不告汝者，非謂尔当客多言，因客粗知医，并非名手，故不当客告汝。汗即血化，此丹溪朱震亨之論，张景岳虽議駁其非，究竟不能指实出汗之本源。古人立論之錯，錯在不知人气血是两管，气管通皮肤有孔窍，故发汗；血管通皮肤无孔窍，故不发汗。何以知血管通皮肤无孔窍？尔看生疮破流黄水者，其毒由气管而来，每日常流黄水，其皮肤不紅；疮毒若在血管，初起皮肤必紅，必待皮肤溃烂，所流必是脓血。尔在看瘟毒、发癍、出疹、小儿出痘，色虽紅而不流血，岂不是血管通皮肤无孔窍之明証乎？侄作礪来京，因閑談問余。彼时是书业已刻成，故书于卷末以記之。

0038482

Document generated by Anna’s Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection
(https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):
{
  "filename": "MTAyMjg4MTcuemlw",
  "filename_decoded": "10228817.zip",
  "filesize": 3881104,
  "md5": "69ed8221da504641bac44cf64d9d969a",
  "header_md5": "722e37cf2a9c40a1770914de3581f767",
  "sha1": "7cbf71d10525e4a812e52df886d3733ed010947d",
  "sha256": "cf7b5444ce2c54b92b85d88ff5ae6037b6681f6e37f89e3a6f49332c0c15f0ec",
  "crc32": 2023998402,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 4002883,
  "pdg_dir_name": "",
  "pdg_main_pages_found": 50,
  "pdg_main_pages_max": 50,
  "total_pages": 56,
  "total_pixels": 41266468,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}